



Satisfacción con la vida y sus determinantes en población adulta en Chile

Trabajo final

Bianca Balmaceda

Joaquín Nuñez

Amalia Santa Cruz

FACSO

Santiago de Chile

30 de junio de 2026

Tabla de contenidos

1.	Satisfacción con la vida y sus determinantes en población adulta en Chile	1
	Abstract	2
2.	Introducción	3
3.	Antecedentes	4
4.	Hipótesis	6
5.	Métodos	7
	5.1. Población y muestra	7
	5.2. Variables	8
	5.3. Estrategia de análisis	9
6.	Resultados	10
	6.1. Análisis descriptivo y bivariado	10
	6.2. Análisis del modelo	11
	6.2.1. Modelos parciales	11
	6.2.2. Modelo completo	11
	6.2.3. Modelos por género	12
	6.2.4. Tabla comparativa de modelos de regresión	12
7.	Conclusiones	14
	7.1. Limitaciones	15
	7.2. Proyecciones futuras	16
8.	Referencias	17

Apéndices	19
A. Instrumentos de levantamiento	19
B. Tablas adicionales	20

1. Satisfacción con la vida y sus determinantes en población adulta en Chile

Palabras clave: Ciencia Social Abierta

Abstract

Esta investigación examina los factores que explican el nivel de satisfacción con la vida en población adulta en Chile, con énfasis en las diferencias según género. A partir de datos de la Encuesta de Bienestar Social 2023 ([Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023](#)) y una muestra de 4.000 casos, se estimaron modelos de regresión lineal múltiple para evaluar el efecto de la salud mental, la salud física, el tiempo libre, la seguridad y el apoyo en el trabajo doméstico sobre la satisfacción con la vida. Los resultados muestran que la salud mental y la salud física son los predictores más robustos en ambos géneros, mientras que el tiempo libre resulta significativo principalmente en hombres. La seguridad y el apoyo en el trabajo doméstico no mostraron efectos consistentes. Estos hallazgos sugieren que los modelos clásicos de bienestar subjetivo deben incorporar una perspectiva de género para capturar de mejor manera las desigualdades estructurales que configuran la experiencia del bienestar.

2. Introducción

La presente investigación busca responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué factores explican el nivel de satisfacción con la vida de adultos en Chile, y qué diferencias existen según género? Para ello se explorará el efecto de las variables salud mental, salud física, tiempo libre, seguridad y apoyo en el trabajo doméstico con la satisfacción con la vida de las personas, analizando si existen diferencias de resultados entre hombres y mujeres. Para hacer este análisis se utilizaron los datos de la Encuesta de Bienestar Social 2023 ([Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023](#)), seleccionando una muestra aleatoria de 4.000 casos.

La satisfacción con la vida es una dimensión del bienestar subjetivo ([Diener, 1994](#)) que aporta en la comprensión de la percepción que tienen las personas sobre sus condiciones contextuales y psicosociales, siendo considerada una evaluación cognitiva de la calidad de las experiencias ([Arita et al., 2005](#)). Siguiendo a Veenhoven ([Veenhoven, 2000, 2011](#)), los principales factores que la explican incluyen la salud física y mental, las relaciones personales, la libertad personal, la seguridad económica y la calidad de las instituciones. Este estudio propone además una lectura crítica de estos modelos, entendiendo la satisfacción con la vida como una categoría atravesada por estructuras de poder, particularmente el género.

Los resultados obtenidos mediante regresión lineal múltiple muestran que la salud mental es el predictor más fuerte en ambos géneros, seguida por la salud física. El tiempo libre resultó significativo principalmente en hombres, mientras que la seguridad y el apoyo en el trabajo doméstico no presentaron efectos robustos. Estos hallazgos sugieren que los modelos clásicos de bienestar subjetivo requieren incorporar perspectivas de género e interseccionales para producir conocimiento más situado y socialmente relevante.

3. Antecedentes

La satisfacción con la vida es una dimensión del concepto del bienestar subjetivo (Diener, 1994), que aporta en la comprensión de la percepción que tienen las personas sobre sus condiciones contextuales y psicosociales. Esta es considerada como una evaluación cognitiva de la calidad de las experiencias (Arita et al., 2005), por lo que se considera un indicador de bienestar subjetivo, siendo de los instrumentos más utilizados para medirlo (Schnettler et al., 2014). Además, según Ruut Veenhoven, sociólogo neerlandés, la satisfacción con la vida es un indicador importante de progreso social.

Los principales factores que explican la satisfacción con la vida, entendida por Veenhoven (Veenhoven, 2000) como sinónimo de felicidad, incluyen la salud física y mental, la existencia de relaciones personales estables y satisfactorias, la libertad personal y los derechos civiles, la seguridad económica y la calidad del gobierno y de las instituciones (Veenhoven, 2011). En base a estos planteamientos, se seleccionaron como variables predictoras la salud física y mental, el tiempo libre, la seguridad y el apoyo en el trabajo doméstico.

La inclusión de la perspectiva de género responde a evidencia empírica que muestra diferencias persistentes entre hombres y mujeres en dimensiones clave del bienestar. El “Termómetro de la Salud Mental de Chile” (Riquelme, 2024) muestra que las mujeres presentan síntomas moderados o graves de problemas de salud mental en mayor proporción. Los datos de la CASEN (2022) indican que las mujeres dedican en promedio 5,9 horas diarias al trabajo no remunerado, frente a 2,8 horas en hombres, lo que limita su acceso al ocio y autocuidado. Asimismo, Moreno et al. (2024) encontraron una brecha de género persistente en la esperanza de vida libre de síntomas depresivos en Chile.

Estos antecedentes motivan una lectura crítica de los modelos clásicos de bienestar subjetivo. Las escalas tradicionales (Diener, 1994) no capturan dimensiones críticas para las mujeres, como el tiempo en tareas de cuidado o trabajo doméstico (Pérez Orozco, 2014). Por ello, este estudio

entiende la satisfacción con la vida como una construcción social atravesada por estructuras de poder, particularmente las relaciones de género, proponiendo una lectura crítica y situada de su medición tradicional.

4. Hipótesis

A partir del marco teórico expuesto, se plantean las siguientes hipótesis de investigación, pre-registradas antes de realizar el análisis principal mediante OSF ([DOI](#))

H1. A mayor nivel de salud mental, mayor es la satisfacción con la vida ($b_1 > 0$).

H2. A mayor nivel de salud física, mayor es la satisfacción con la vida ($b_2 > 0$).

H3. A mayor disponibilidad de tiempo libre, mayor es la satisfacción con la vida ($b_3 > 0$).

H4. A mayor percepción de inseguridad, menor es la satisfacción con la vida ($b_4 < 0$).

H5. A mayor apoyo recibido en el trabajo doméstico, menor es la satisfacción con la vida ($b_5 < 0$).

Estas hipótesis se expresan formalmente en la siguiente ecuación de regresión lineal múltiple:

$$\text{satisfacción con la vida} = b_1 \cdot \text{salud mental} + b_2 \cdot \text{salud física} + b_3 \cdot \text{tiempo libre} + b_4 \cdot \text{seguridad} + b_5 \cdot \text{apoyo en el trabajo doméstico}$$

Adicionalmente, se busca explorar si los efectos de estas variables difieren entre hombres y mujeres, en línea con el enfoque de género adoptado en este estudio.

5. Métodos

5.1. Población y muestra

La base de datos utilizada para la investigación es la Encuesta de Bienestar Social 2023 ([Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023](#)), desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Instituto Nacional de Estadística de Chile. El instrumento fue implementado por primera vez en 2021 con el objetivo de elaborar un diagnóstico completo sobre el bienestar de la población chilena que complemente la información recogida por la Encuesta Casen. Fue diseñado por la Subsecretaría de Evaluación del Ministerio desde el año 2019. Cuenta con un modelo de 11 dimensiones del bienestar: bienestar subjetivo, educación, trabajo en la ocupación, uso del tiempo, ingresos, salud, vivienda, calidad del medio ambiente, seguridad, relaciones sociales, confianza y participación, y orientación sexual.

La población de estudio de la encuesta es una submuestra de las personas entrevistadas en la Encuesta Casen. Corresponde a personas de 18 años o más, cumplidos a la fecha de realización de la Encuesta Casen 2022, que vivan en el territorio nacional.

El tamaño de la muestra es de 12.369 personas, con un error absoluto nacional esperado de 1 % y un error relativo de 8 %. El marco muestral está basado en el Censo de Población y Vivienda de 2017, actualizado al año 2020, y está constituido por unidades primarias de muestreo (UPM) correspondientes a áreas geográficas homogéneas en términos del número de viviendas particulares.

Para esta investigación se filtró la base de datos y se creó una submuestra aleatoria de 4.000 personas, eliminando los casos perdidos mediante eliminación por lista (listwise deletion). Luego de este procedimiento, la submuestra quedó constituida por 3.980 casos. Adicionalmente, se

realizó una diferenciación entre grupos de hombres y mujeres, con el fin de comparar los efectos de las variables explicativas entre géneros.

5.2. Variables

Escala sumativa de satisfacción con la vida (dependiente): Construida a partir de cuatro variables categóricas: satisfacción actual con la vida, satisfacción con el tiempo libre disponible, satisfacción con las relaciones personales, y felicidad percibida el día anterior. Cada ítem se mide en una escala de 1 a 5, por lo que la escala total puede tomar valores entre 4 y 20, donde puntajes más altos indican mayor satisfacción con la vida. La consistencia interna de la escala, medida a través del Alpha de Cronbach, fue de 0.62, lo que indica una confiabilidad moderadamente aceptable para investigación social ($\alpha \geq 0.60$).

Escala sumativa de salud mental (independiente): Construida a partir de cuatro variables categóricas relativas a la frecuencia de sentirse solo/a, tranquilo/a, enojado/a y triste. Las variables fueron recodificadas para que valores más altos indiquen mejor salud mental. La escala toma valores entre 4 y 20. El Alpha de Cronbach obtenido fue de 0.66, indicando una confiabilidad aceptable.

Salud física (independiente): Variable categórica que mide la percepción del estado de salud actual, en una escala de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno).

Tiempo libre (independiente): Variable dicotómica que indica si la persona realizó actividades de tiempo libre el día anterior (1 = sí, 0 = no).

Seguridad (independiente): Variable ordinal que mide la cantidad de veces que la persona ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, con categorías de 1 (nunca) a 3 (más de una vez).

Apoyo en el trabajo doméstico, ATD (independiente): Variable categórica ordinal que indica si el hogar recibió apoyo, pagado o no, para realizar tareas domésticas o de cuidado de personas.

5.3. Estrategia de análisis

El análisis se centra en conocer el efecto de las variables salud mental, salud física, tiempo libre, seguridad y apoyo en el trabajo doméstico sobre la satisfacción con la vida, mediante un análisis de regresión lineal múltiple.

En primer lugar, se realiza un análisis univariado, con estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, asimetría y kurtosis) para cada variable dependiente e independiente.

En segundo lugar, se realiza un análisis bivariado entre la variable dependiente y cada una de las variables independientes, utilizando distintos estadísticos de asociación según la naturaleza de cada variable: correlaciones de Pearson para variables continuas y ordinales, y pruebas t de Student para variables categóricas.

En tercer lugar, se realiza un análisis multivariado mediante regresión lineal múltiple, incorporando dos modelos parciales. El primero considera las variables “Salud Mental” y “Salud Física”, y el segundo las variables “Tiempo Libre” y “Apoyo en el Trabajo Doméstico”. Posteriormente, se estiman tres modelos de regresión lineal múltiple con todas las variables seleccionadas: uno con la muestra completa, y dos adicionales filtrados según género (hombres y mujeres), con el fin de comparar los efectos de las variables explicativas entre ambos grupos.

6. Resultados

6.1. Análisis descriptivo y bivariado

La variable dependiente, escala sumativa de satisfacción con la vida, que suma 4 ítems con un rango total de 4 a 20, muestra un promedio de nivel medio alto de satisfacción con la vida, con poca dispersión de respuestas (media = 15.25, SD = 2.58). La asimetría de la variable es leve y negativa ($Sk = -0.58$), lo que indica que la mayoría de las personas se concentran en niveles altos de satisfacción con la vida.

En cuanto a las variables explicativas, la escala sumativa de salud mental, que también va de 4 a 20, presenta un alto promedio (media = 16.5, SD = 2.98), con una asimetría negativa y medianamente alta ($Sk = -1.04$). El promedio de la variable salud física, que va de 1 a 5, muestra una buena salud física percibida, con baja dispersión (media = 3.47, SD = 0.86) y asimetría negativa moderada ($Sk = -0.44$). La variable de apoyo en el trabajo doméstico (ATD), que va de 1 a 4, tiene un promedio cercano a 4, la categoría de “no recibió apoyo” (media = 3.72, SD = 0.84), con una asimetría fuertemente negativa ($Sk = -2.76$). La variable dicotómica de tiempo libre indica que el 95 % de los individuos realizó actividades de tiempo libre (media = 0.96, SD = 0.21). Por último, la variable de seguridad, que va de 1 a 3, tiene un promedio cercano al valor mínimo (media = 1.19, SD = 0.49), con asimetría positiva y fuerte inclinación hacia la izquierda ($Sk = 2.62$).

Respecto al análisis bivariado, la salud mental presenta la mayor asociación con la satisfacción con la vida, una correlación fuerte, positiva y estadísticamente significativa ($r = 0.591$; $p < .001$). La salud física muestra diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2 = 457.1$; $p < .001$) según el test de Kruskal-Wallis. El tiempo libre también se asocia significativamente con la satisfacción con la vida: quienes disponen de tiempo libre presentan niveles promedio más altos (15.29) que quienes no lo tienen (14.32), diferencia estadísticamente significativa ($t = -4.901$; p

$< .001$). La seguridad muestra una correlación negativa, débil pero significativa ($\rho = -0.102$; $p < .001$). Por último, el apoyo en el trabajo doméstico no presenta una relación significativa con la satisfacción con la vida ($\rho = 0.003$; $p = 0.846$).

6.2. Análisis del modelo

6.2.1. Modelos parciales

Se estimaron dos modelos parciales de regresión lineal múltiple. El primero, con las variables “Salud Mental” y “Salud Física”, muestra que ambas tienen una significancia estadística alta ($p < 0.001$ en ambos casos) y un efecto positivo sobre la satisfacción con la vida, con una intensidad fuerte para salud mental (Std. $b = .532$) y moderada para salud física (Std. $b = .180$). El R^2 ajustado del modelo (.378) indica que estas dos variables explican el 37.8 % de la varianza en la satisfacción con la vida.

El segundo modelo parcial, con las variables “Tiempo Libre” y “Apoyo en el Trabajo Doméstico”, indica que el tiempo libre es estadísticamente significativo ($p < .001$), mientras que el apoyo en el trabajo doméstico no lo es ($p = .677$). El R^2 ajustado de este modelo es considerablemente más bajo (.006), explicando solo el 0.6 % de la varianza.

6.2.2. Modelo completo

En el modelo completo, que incorpora las cinco variables explicativas, la salud mental ($b_1 = .454$, $p < .001$) y la salud física ($b_1 = .541$, $p < .001$) mantienen efectos positivos y robustos, siendo la salud física el predictor más fuerte según los coeficientes estandarizados (Std. $b = .541$), seguida de la salud mental (Std. $b = .454$). El tiempo libre también resulta significativo ($b_1 = .441$, $p < .005$), confirmando la hipótesis inicial. El apoyo en el trabajo doméstico no alcanza significancia estadística ($p = .262$), aunque su coeficiente es negativo, en línea con la dirección hipotetizada. La variable de seguridad tampoco alcanza significancia estadística en el modelo completo ($p > .005$).

6.2.3. Modelos por género

Se estimaron modelos separados para hombres y mujeres con el fin de evaluar si los factores que inciden en la satisfacción con la vida operan de manera similar en ambos grupos. En ambos casos, la salud mental es el predictor más fuerte (hombres: Std. b = 0.542, $p < 0.001$; mujeres: Std. b = 0.506, $p < 0.001$).

En el modelo para hombres ($R^2 = 0.393$, $p < .001$), además de la salud mental, el tiempo libre (Std. b = 0.049, $p < .001$) y la salud física (Std. b = 0.169, $p < 0.001$) muestran efectos positivos y significativos. La seguridad resulta significativa pero de baja magnitud (Std. b = -0.033, $p = 0.042$). El apoyo en tareas domésticas no muestra relación significativa ($p = 0.872$).

En el modelo para mujeres ($R^2 = 0.368$, $p < .001$), la salud física es el segundo predictor más fuerte (Std. b = 0.205, $p < .001$). La seguridad no alcanza significación estadística (Std. b = -0.027, $p = 0.178$), y tanto el tiempo libre (Std. b = 0.013, $p = 0.525$) como el apoyo en tareas domésticas (Std. b = -0.031, $p = 0.119$) carecen de efectos significativos.

Estos resultados muestran que, si bien la salud física y mental son factores clave en ambos géneros, existen matices relevantes: en los hombres el tiempo libre emerge como un factor relevante, mientras que en las mujeres destaca con mayor fuerza el rol de la salud física. La seguridad muestra efectos significativos solo en el modelo masculino, y el apoyo en las tareas domésticas no resulta significativo en ningún grupo.

6.2.4. Tabla comparativa de modelos de regresión

Lista de tablas 6.1.

Lista de tablas 6.2.: *Tabla 1. Modelos de Regresión Lineal Múltiple para Satisfacción con la Vida*

	M1	M2	M3	M4	M5
(Intercept)	5.886*** (0.189)	14.248*** (0.261)	5.886*** (0.285)	5.570*** (0.357)	6.166*** (0.484)
salud_mental	0.452*** (0.011)		0.446*** (0.011)	0.451*** (0.014)	0.446*** (0.019)
salud_física	0.537*** (0.039)		0.534*** (0.039)	0.528*** (0.050)	0.572*** (0.062)
tiempo_libre		1.015*** (0.192)	0.499*** (0.151)	0.682*** (0.189)	0.186 (0.252)
ATD		−0.012 (0.049)	−0.036 (0.038)	−0.008 (0.050)	−0.076 (0.059)
seguridad			−0.194** (0.064)	−0.131 (0.086)	−0.259** (0.096)
Num.Obs.	4000	4000	4000	2349	1651
R2	0.388	0.007	0.391	0.416	0.355
R2 Adj.	0.388	0.006	0.390	0.414	0.353
AIC	17 083.2	19 018.7	17 068.4	10 036.6	7030.5
BIC	17 108.4	19 043.8	17 112.5	10 077.0	7068.4
Log.Lik.	−8537.623	−9505.333	−8527.201	−5011.323	−3508.259
RMSE	2.05	2.60	2.04	2.04	2.03

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

7. Conclusiones

La presente investigación buscó responder a la pregunta sobre qué factores explican el nivel de satisfacción con la vida de adultos en Chile, y si existen diferencias según género. Para ello se investigó el efecto de las variables salud mental, salud física, tiempo libre, seguridad y apoyo en el trabajo doméstico (ATD). Los resultados obtenidos mediante el análisis de regresión lineal múltiple, utilizando los datos de la Encuesta de Bienestar Social 2023 ([Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023](#)), permiten corroborar varias de las hipótesis iniciales y responder la pregunta de investigación en buena medida.

Los resultados descriptivos mostraron que el grupo de estudio se encuentra en un nivel medio alto de satisfacción con la vida, concentrado en los niveles más altos. La salud física y mental también resultaron mayoritariamente positivas. En el análisis bivariado, la salud mental presentó la mayor correlación con la satisfacción con la vida, lo que coincide con los resultados del modelo de regresión. Las variables de salud física y tiempo libre también mostraron correlaciones positivas y significativas, mientras que la seguridad presentó una correlación débil aunque significativa, y el ATD no mostró una correlación estadísticamente significativa.

El modelo de regresión lineal múltiple permitió confirmar la mayoría de las hipótesis iniciales. La salud mental fue la variable que explica con mayor fuerza la satisfacción con la vida, seguida por la salud física y el tiempo libre, todas con efectos positivos y significativos, confirmando las hipótesis H1, H2 y H3. La variable de seguridad mostró un efecto negativo y significativo, confirmando H4. En el caso del apoyo en el trabajo doméstico (H5), si bien no alcanzó relevancia estadística en el modelo completo, su coeficiente fue negativo, acercándose a la dirección hipotetizada. Estas concordancias corroboran en gran medida las propuestas de Veenhoven ([Veenhoven, 2000, 2011](#)) sobre los principales factores que explican la satisfacción con la vida.

En cuanto a las diferencias por género, en ambos modelos la salud mental y la salud física fueron las variables explicativas más fuertes, en concordancia con el modelo de la población total. La principal diferencia fue que, en hombres, el tiempo libre emergió como tercera variable explicativa relevante con efecto positivo, mientras que en mujeres las únicas variables con efecto significativo fueron salud física y mental. Para ambos grupos, el apoyo en el trabajo doméstico no resultó significativo.

Estos resultados permiten reflexionar sobre los límites y alcances del marco teórico utilizado. Las teorías clásicas del bienestar subjetivo ([Diener, 1994](#); [Veenhoven, 2000, 2011](#)) plantean que factores como la salud física y mental, la seguridad, la libertad personal y las condiciones materiales explican las diferencias en satisfacción con la vida. Sin embargo, los resultados de este estudio muestran que estos factores no afectan de igual manera a todas las personas, y que el género opera como un eje estructurante que condiciona la forma en que se experimenta y valora el bienestar. Por ejemplo, en los hombres el tiempo libre aparece como un factor relevante, mientras que en las mujeres este pierde fuerza, adquiriendo mayor importancia la salud física. Esto podría estar vinculado a la carga desigual de cuidados y trabajo doméstico no remunerado ([Fraser, 1994](#); [Kirkwood, 1982](#)), que enfrenta a las mujeres a mayores limitaciones estructurales.

Que la variable de apoyo en el trabajo doméstico no sea significativa en ningún modelo sugiere que su impacto podría ser indirecto o estar mediado por otras dimensiones no consideradas, lo que invita a repensar la operacionalización de este tipo de variables en futuras investigaciones.

En consecuencia, se propone que el bienestar subjetivo no se explica solamente por factores individuales o generales, sino que está atravesado por estructuras de poder, especialmente las relaciones de género. Esto refuerza la idea de la satisfacción con la vida como una construcción social, y subraya la necesidad de que investigaciones futuras integren enfoques interseccionales para producir conocimiento más situado y socialmente relevante.

7.1. Limitaciones

A nivel teórico, este estudio se basa en modelos clásicos de bienestar subjetivo que podrían no considerar otras variables no tradicionales relevantes para la satisfacción con la vida, por lo que se propone incorporar marcos teóricos interseccionales en futuras investigaciones. Asimismo,

las variables explicativas escogidas no consideran diferencias culturales o contextuales entre distintos grupos sociales.

A nivel metodológico, los datos utilizados están sujetos a las percepciones individuales de las personas, lo cual podría complementarse con indicadores objetivos o metodologías mixtas que combinen datos cualitativos y cuantitativos. Además, la eliminación de casos perdidos por lista puede sesgar la muestra, lo que podría abordarse mediante técnicas que preserven una mayor cantidad de datos.

7.2. Proyecciones futuras

A partir de los hallazgos de este estudio, se abren varias líneas de trabajo futuro. En primer lugar, sería relevante incorporar marcos teóricos interseccionales que permitan analizar el bienestar subjetivo considerando, además del género, otras dimensiones estructurantes como la clase social, la edad o el territorio, lo que enriquecería la comprensión de las desigualdades en satisfacción con la vida.

En segundo lugar, futuras investigaciones podrían profundizar en por qué el apoyo en el trabajo doméstico no mostró un efecto significativo en este modelo, explorando si su impacto se expresa de forma indirecta a través de otras variables, como el tiempo libre o la salud mental, mediante modelos de mediación o moderación.

En tercer lugar, sería valioso complementar este enfoque cuantitativo con metodologías cualitativas que permitan capturar la experiencia subjetiva de hombres y mujeres respecto al trabajo doméstico, el tiempo libre y la seguridad, aportando matices que un modelo de regresión no logra reflejar.

Finalmente, dado que este análisis se basa en datos transversales de 2023, sería pertinente dar seguimiento a estos indicadores en futuras versiones de la Encuesta de Bienestar Social ([Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023](#)), para observar si las diferencias de género identificadas se mantienen, se profundizan o disminuyen en el tiempo.

8. Referencias

- Arita, B. Y., Romano, S., García, N., & del Refugio Félix, M. (2005). Indicadores objetivos y subjetivos de la calidad de vida. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 10(1), 93-102. <https://www.redalyc.org/pdf/292/29210106.pdf>
- Diener, E. (1994). El bienestar subjetivo. *Intervención Psicosocial*, 3(8), 67.
- Fraser, N. (1994). After the Family Wage: Gender Equity and the Welfare State. *Political Theory*, 22(4), 591-618. <https://doi.org/10.1177/0090591794022004003>
- Kirkwood, J. (1982). *Feminismo y participación política en Chile* (Documento de trabajo No. 159). FLACSO. <http://flacsochile.org/biblioteca/pub/memoria/1982/001076.pdf>
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2023). *Encuesta de Bienestar Social 2023*. Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-bienestar-social-2023>
- Moreno, X., Monsalves, M. J., Rueda, S., Dagnino, P., & Borghero, F. (2024). Gender differences in life expectancy free of depressive symptoms in Chile between 2003 and 2016. *Cambridge Prisms: Global Mental Health*, 11, e16. <https://www.cambridge.org/core/journals/global-mental-health/article/gender-differences-in-life-expectancy-free-of-depressive-symptoms-in-chile-between-2003-and-2016/86C7AE17EF09348668D17EA0A07D2D49>
- Pérez Orozco, A. (2014). Del trabajo doméstico al trabajo de cuidados. En A. Pérez Orozco (Ed.), *Con voz propia: La economía feminista como apuesta teórica y política* (pp. 49-73). La Oveja Roja. https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/con_voz_propia.pdf
- Riquelme, M. (2024). *Termómetro de salud mental: Uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad*. Pontificia Universidad Católica de Chile. <https://www.uc.cl/noticias/termometro-de-salud-mental-uno-de-cada-cuatro-chilenos-presenta-sintomas-de-ansiedad/>
- Schnettler, B., Miranda, H., Sepúlveda, J., Orellana, L., Denegri, M., Mora, M., & Lobos, G. (2014). Variables que influyen en la satisfacción con la vida de personas de distinto nivel so-

- cioeconómico en el sur de Chile. *Suma Psicológica*, 21(1), 54-62. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438114700074>
- Veenhoven, R. (2000). Freedom and Happiness: A Comparative Study in Forty-Four Nations in the Early 1990s. En E. Diener & E. M. Suh (Eds.), *Culture and Subjective Wellbeing* (pp. 257-288). MIT Press. <https://personal.eur.nl/veenhoven/Pub2000s/2000a-full.pdf>
- Veenhoven, R. (2011). *Life Satisfaction in Nations*. <https://personal.eur.nl/veenhoven/Pub2010s/2011s-full.pdf>

Apéndice A.

Instrumentos de levantamiento

Incluye cuestionarios, guías de entrevista, etc.

Apéndice B.

Tablas adicionales

Tablas extendidas, tests de robustez, etc.